

末梢静脈穿刺の神経損傷について

(1) 穿刺時、神経損傷を起こさない為の予防法

- ① 手首の手掌側、橈骨、肘の内側への穿刺は避ける。
- ② 利き腕は極力避ける。
- ③ 穿刺は手首から12cm程度中枢側で行う。
- ④ 血管の真上から15～30度の角度で穿刺する。
- ⑤ 皮膚に金属針を穿刺したまま周囲を探ったり、必要以上に深く刺さない。
- ⑥ 2回穿刺に失敗したら、穿刺者を交代する。
- ⑦ 痛み痺れの訴えがあれば直ちに抜針する。
- ⑧ 抜針後も症状が続く時は医師に連絡する。

(2) 注射・採血時に患者が「痛み」「痺れ」を訴えた場合の対応

神経損傷を疑い、直ちに治療が必要な症状

- ① 針を進めているときの電撃痛 ② 末梢又は中枢への放散痛
- ③ 抜針後も続く耐えられないような痛み

駆血帯をゆるめ、直ちに針を抜く

患部は伸展させず、良肢位で、神経を少し緩める感じに保ち、疼痛・しびれの部位、範囲を調べる。穿刺部がわかるように、テープ等で印をつける。



医師に連絡するとともに、局所の安静と保温を保つ。



抜針後、10～30分経っても痛み・しびれを来す場合、医師は、穿刺部位、痛み・しびれの部位・程度を記録し、整形外科および神経内科などの受診を決定する。

「痛み」「痺れ」が抜針により消失した場合

一旦、症状が消失しても、後で、痛みや痺れが、また出現する場合もあるので、そのときは、すぐに連絡するよう、患者に伝える。外来患者の場合は、患者が帰宅後、状況に応じて、こちらから患者に電話連絡し、様子を見る。